



CAM — Confusion Assessment Method

RASTREIO E DIAGNÓSTICO DE DELIRIUM

Paciente _____ Data _____
Local / contexto _____ Horário _____ Avaliador _____

ANTES DE APLICAR

Aplique após uma breve entrevista com o paciente e converse com quem o conhece: os itens 1 e 4 dependem da comparação com o estado habitual. O CAM não substitui a busca da causa — delirium é sempre sinal de doença aguda até prova em contrário.

Os quatro critérios

Critério	Presente	Ausente
1. Início agudo e curso flutuante — houve mudança aguda do estado mental em relação ao habitual? O comportamento oscilou ao longo do dia, indo e voltando ou variando de intensidade?	☐	☐
2. Desatenção — o paciente teve dificuldade para focar a atenção, distraiu-se com facilidade ou teve dificuldade em acompanhar o que era dito?	☐	☐
3. Pensamento desorganizado — o pensamento esteve desorganizado ou incoerente, com conversa dispersa ou irrelevante, fluxo de ideias pouco claro ou mudança imprevisível de assunto?	☐	☐
4. Alteração do nível de consciência — o nível de consciência esteve diferente de alerta: vigilante, letárgico, torporoso ou comatoso?	☐	☐

Delirium provável quando: critério 1 e critério 2 estão presentes, associados ao critério 3 ou ao critério 4.

CONCLUSÃO

Resultado: ☐ CAM negativo ☐ CAM positivo — delirium provável

Apresentação: ☐ Hiperativo ☐ Hipoativo ☐ Misto

Como testar a atenção à beira do leito

Peça para dizer os meses do ano de trás para frente, de dezembro a janeiro, ou os dias da semana em ordem inversa. Outra opção é a repetição de sequências de dígitos. Falhas grosseiras ou necessidade de reiniciar várias vezes sugerem desatenção.



Causas a investigar

ROTEIRO RÁPIDO

Medicamentos — anticolinérgicos, benzodiazepínicos, opioides, corticoides, introdução ou retirada recente.

Infecção — urinária, respiratória, pele e partes moles.

Metabólico — desidratação, distúrbio de sódio, glicemia, uremia, hipóxia, tireoide.

Dor e retenção — dor não controlada, retenção urinária, fecaloma.

Neurológico e cardiovascular — AVC, trauma craniano, crise convulsiva, síndrome coronariana, arritmia.

Ambiente — privação de sono, imobilidade, contenção, ausência de óculos e aparelho auditivo, mudança de ambiente.

A forma hipoativa é a mais comum no idoso e a mais subdiagnosticada: sonolência e quietude costumam ser lidas como melhora ou como depressão. Na dúvida entre delirium e demência, o que distingue é o início agudo, a flutuação e a desatenção.

Impressão e conduta

Dr. Pedro H. Dias Lino

Médico | CRM-7618 | RQE-4251

Referência: Inouye SK, van Dyck CH, Alessi CA, et al. Clarifying confusion: the Confusion Assessment Method. Ann Intern Med. 1990;113(12):941–948. • Fabbri RMA, Moreira MA, Garrido R, Almeida OP. Validity and reliability of the Portuguese version of the Confusion Assessment Method. Arq Neuropsiquiatr. 2001;59(2-A):175–179.